

Nghiên cứu chuyên sâu về giấc ngủ

Bản nháp v0.1, ngày 05/10/2026. Tài liệu nền cho trụ **Ngủ nghỉ** của Lục Dưỡng, bổ sung cho *Cơ chế trụ Ngủ nghỉ*. Ký hiệu: ☼ = Lục Dưỡng vận dụng; [C1] [C2] [C3] = cấp bằng chứng (lý luận v0.3, mục IX).

Trạng thái kiểm chứng: các nguồn đánh dấu **(đã kiểm)** đã được đối chiếu sơ bộ qua tra cứu trực tuyến ngày 05/10/2026 (xem mục "Nguồn" cuối tài liệu). Các nguồn còn lại viết từ hiểu biết chung, **cần kiểm tra lại** trước khi trích dẫn công khai. Toàn bộ tài liệu cần bác sĩ chuyên về giấc ngủ và lương y thẩm định.

Mục lục

- Vì sao giấc ngủ là trụ nền
- Sinh lý giấc ngủ: hai quá trình điều khiển
- Kiến trúc giấc ngủ: chu kỳ và giai đoạn
- Chức năng của từng giai đoạn
- Giấc ngủ thay đổi theo tuổi, giới và kiểu thời sinh học
- Đông lý về giấc ngủ
- Đối chiếu Đông - Tây
- Hậu quả của thiếu ngủ
- Các rối loạn giấc ngủ thường gặp
- Can thiệp theo cấp bằng chứng
- Đo lường giấc ngủ
- Ứng dụng cho Cội Wellness
- Câu hỏi nghiên cứu mở cho Lục Dưỡng
- Nguồn

1. Vì sao giấc ngủ là trụ nền

- Giấc ngủ chiếm khoảng **một phần ba đời người** và tác động lên **cả bốn tầng**: Thân (phục hồi, chuyển hoá), Khí (năng lượng), Tâm (điều tiết cảm xúc), Thần (tập trung, trí nhớ).
- Trong bảng "sáu trụ nuôi bốn tầng" (lý luận v0.3), Ngủ nghỉ là trụ duy nhất có **hai ô** ●●● (Thân và Thần).
- Giấc ngủ là **điểm giao** của nhiều trụ: ăn uống (cà phê, rượu, bữa tối), luyện tập, thiền, cảm xúc, môi trường (ánh sáng, tiếng ồn). Cải thiện giấc ngủ thường kéo theo các trụ khác.

Tình hình ở Việt Nam

Dữ liệu dịch tễ quốc gia về giấc ngủ ở Việt Nam **còn ít và không đồng nhất về phương pháp**. Một số số liệu đã công bố:

Nhóm	Số liệu	Nguồn
Cộng đồng dân cư TP.HCM	Khoảng 33% có ít nhất một triệu chứng mất ngủ	Khảo sát của Bệnh viện Tâm thần TP.HCM (đã kiểm)
Sinh viên đại học TP.HCM	24,9% mất ngủ (trên 2.034 sinh viên)	<i>Tạp chí Y học Việt Nam</i> (đã kiểm)
Người trẻ	Khoảng 37% mất ngủ (khảo sát báo chí, phương pháp chưa rõ)	VnExpress (đã kiểm nguồn, chưa kiểm phương pháp)
Toàn quốc	Ước tính trên 10 triệu người có vấn đề giấc ngủ, khoảng 4 triệu người ngáy, ngưng thở khi ngủ (ước tính, cần nguồn gốc)	Sở Y tế Nghệ An dẫn lại (đã kiểm nguồn, chưa kiểm phương pháp)

→ **Hệ quả:** Lục Dưỡng có cơ hội đóng góp dữ liệu tổng hợp ẩn danh (lý luận mục IX, bậc 3) về giấc ngủ người Việt, nếu được thiết kế đúng chuẩn đạo đức.

2. Sinh lý giấc ngủ: hai quá trình điều khiển

Mô hình hai quá trình (Borbély, 1982) là khung giải thích nền tảng [C1]:

Quá trình	Bản chất	Diễn biến
Quá trình S: áp lực ngủ	Chất adenosine (và các yếu tố khác) tích tụ trong não khi thức	Tăng dần suốt thời gian thức, giảm khi ngủ, nhất là khi ngủ sâu
Quá trình C: đồng hồ sinh học	Nhân trên chéo (vùng dưới đồi) điều khiển nhịp ngày đêm khoảng 24 giờ; ánh sáng là tín hiệu chỉnh giờ mạnh nhất	Tạo "cửa sổ" buồn ngủ ban đêm và tín hiệu tỉnh táo ban ngày

Buồn ngủ xuất hiện khi áp lực ngủ cao và đồng hồ mở cửa sổ ngủ. Từ đó suy ra:

- Ngủ trưa dài, ngủ muộn buổi chiều** xả bớt áp lực ngủ → tối khó ngủ.
- Caffeine** chặn thụ thể adenosine → che giấu áp lực ngủ.
- Ánh sáng buổi tối** đẩy lùi cửa sổ ngủ; **ánh sáng buổi sáng** kéo cửa sổ sớm lên.
- Melatonin** do tuyến tùng tiết ra khi trời tối, là **tín hiệu "đêm đã đến"**, không phải "thuốc ngủ tự nhiên".

Các hệ thống liên quan khác

Hệ thống	Vai trò	Cấp
Thân nhiệt	Thân nhiệt lõi giảm vào buổi tối; mạch máu bàn tay, bàn chân giãn để thải nhiệt giúp vào giấc	C1

Hệ thống	Vai trò	Cấp
Cortisol	Đỉnh vào sáng sớm (giúp thức dậy), thấp nhất khoảng nửa đầu đêm	C1
Hệ thần kinh tự chủ	Ngủ sâu: phó giao cảm chiếm ưu thế; REM: dao động mạnh	C1
Hệ kích thích (orexin, noradrenaline...)	Duy trì tỉnh táo; căng thẳng làm hệ này hoạt động quá mức, gây mất ngủ	C1-C2

3. Kiến trúc giấc ngủ: chu kỳ và giai đoạn

Mỗi đêm gồm **4-6 chu kỳ**, mỗi chu kỳ khoảng **90 phút** [C1].

Giai đoạn	Sóng não, đặc điểm	Tỷ lệ ở người trưởng thành
N1	Chuyển tiếp, rất nông, dễ tỉnh	Khoảng 5%
N2	Ngủ nông ổn định; có thoi ngủ và phức hợp K	Khoảng 45-55%
N3 (ngủ sâu, sóng chậm)	Sóng chậm biên độ lớn (0,5-4 Hz); rất khó đánh thức	Khoảng 15-25%
REM	Não hoạt động gần như lúc thức; mắt chuyển động nhanh; cơ gần như liệt; mơ sống động	Khoảng 20-25%

Phân bố trong đêm [C1]:

- **Ngủ sâu** dồn vào **1/3 đầu đêm**.
- **REM** dồn vào **nửa sau đêm**, giai đoạn REM dài dần về sáng.

Hệ quả thực hành:

- Thức khuya nhưng vẫn phải dậy sớm thì **mất phần lớn REM**.
- Giấc đầu đêm bị phá (rượu, ồn, đau, ngưng thở khi ngủ) thì **mất ngủ sâu**.
- Thức giấc ngắn vài lần trong đêm là **bình thường**, nhất là giữa các chu kỳ; thường không nhớ.

4. Chức năng của từng giai đoạn

Ngủ sâu (N3)

Chức năng	Cơ chế	Cấp
Phục hồi thể chất	Đợt tiết hormone tăng trưởng lớn nhất gắn với giấc ngủ sâu đầu tiên	C1
Củng cố trí nhớ sự kiện, kiến thức	Sóng chậm, thoi ngủ và "gợn sóng" hồi hải mã phối hợp, chuyển ký ức sang vỏ não	C1-C2
Cân bằng khớp thần kinh	Giả thuyết của Tononi và Cirelli: ngủ sâu làm khớp thần kinh nhẹ bớt sau một ngày học hỏi	C2

Chức năng	Cơ chế	Cấp
Làm sạch chất thải trong não	Hệ glymphatic tăng hoạt động khi ngủ (nghiên cứu chủ yếu trên chuột, Xie và cộng sự 2013)	C2
Chuyển hoá đường	Cố ý phá ngủ sâu làm giảm độ nhạy insulin (Tasali và cộng sự 2008)	C2
Tim mạch	Nhịp tim, huyết áp giảm về đêm ("trũng huyết áp đêm")	C1

Giấc ngủ nông (N2)

Chức năng	Cấp
Chiếm phần lớn thời gian ngủ; thoi ngủ liên quan củng cố trí nhớ kỹ năng vận động và khả năng "chấn" tiếng động để giữ giấc ngủ	C2

REM

Chức năng	Cơ chế	Cấp
Điều tiết cảm xúc	REM giúp làm dịu "sức nặng cảm xúc" của ký ức; thiếu REM làm phản ứng cảm xúc mạnh hơn	C2
Trí nhớ cảm xúc, sáng tạo, liên kết ý tưởng	Kết nối các mẫu thông tin xa nhau	C2
Phát triển não	REM chiếm tỷ lệ rất cao ở trẻ sơ sinh	C1
Mơ	Mơ sống động chủ yếu trong REM; mơ là hiện tượng bình thường	C1

→ **Không có giai đoạn "tốt" hay "xấu".** Cơ thể cần **cả kiến trúc đầy đủ**. App không nên đặt mục tiêu "% ngủ sâu" hay "% REM".

5. Giấc ngủ thay đổi theo tuổi, giới và kiểu thời sinh học

Nhu cầu ngủ theo tuổi

Nhóm	Khuyến nghị	Nguồn
Người trưởng thành 18-60 tuổi	Ít nhất 7 giờ/đêm	Đồng thuận AASM và SRS 2015 [C1]
Người 65 tuổi trở lên	Khoảng 7-8 giờ	National Sleep Foundation 2015 [C1]

Thay đổi theo tuổi [C1]

- **Ngủ sâu giảm dần** từ tuổi 20-30; ở người cao tuổi có thể rất ít, giảm mạnh hơn ở nam.
- Thức giấc giữa đêm nhiều hơn; hiệu quả giấc ngủ giảm.
- Đồng hồ sinh học có xu hướng **sớm hơn** (buồn ngủ sớm, dậy sớm).
- Ngủ sâu suy giảm ở người cao tuổi đi kèm suy giảm trí nhớ (Mander và cộng sự 2013) [C2].

Theo giới

Hiện tượng	Cấp
Phụ nữ có tỷ lệ mất ngủ cao hơn nam	C1
Giấc ngủ thay đổi theo chu kỳ kinh nguyệt, thai kỳ, sau sinh, tiền mãn kinh và mãn kinh (bốc hoả, đổ mồ hôi đêm)	C1
Nam giới có tỷ lệ ngưng thở khi ngủ cao hơn; ở nữ tăng sau mãn kinh	C1

Kiểu thời sinh học (chronotype)

- Mỗi người có thiên hướng **"chim sơn ca"** (ngủ sớm dậy sớm) hoặc **"cú đêm"** (ngủ muộn dậy muộn), có phần do di truyền [C1].
- Tuổi vị thành niên và người trẻ có xu hướng muộn hơn [C1].
- Lịch giữa đồng hồ sinh học và lịch xã hội ("lịch múi giờ xã hội", social jetlag) liên quan chuyển hoá và tâm trạng kém hơn [C2].

→ **Hệ quả cho Lục Dưỡng:** "dậy sớm là tốt" không đúng cho mọi người. Nguyên tắc vững hơn là **đều đặn** và **đủ giờ**, trong khung giờ phù hợp với cơ thể và công việc.

6. Đông lý về giấc ngủ

6.1. Âm dương và giấc ngủ

- Linh Khu*, "*Khấu vấn*" (**đã kiểm**): **"Dương khí tận, âm khí thịnh, tắc mục minh; âm khí tận nhi dương khí thịnh, tắc ngộ hĩ"**: dương khí hết, âm khí thịnh thì mắt nhắm (ngủ); âm khí hết mà dương khí thịnh thì tỉnh dậy.
- Ngày thuộc dương, đêm thuộc âm. Ngủ là **dương vào âm**, thức là **dương ra khỏi âm**.

6.2. Vệ khí và "hợp âm"

- Cổ truyền mô tả **vệ khí** ban ngày đi ở phần dương (biểu), ban đêm vào phần âm (tạng phủ). Vệ khí vào âm thì ngủ, ra dương thì thức.
- Linh Khu*, "*Doanh vệ sinh hội*" (**đã kiểm**): **"Dạ bán nhi đại hội, vạn dân giai ngọa, mệnh viết hợp âm"**: nửa đêm doanh khí và vệ khí đại hội, muôn dân đều ngủ, gọi là **hợp âm**.

6.3. Thần tàng, hôn yên

- Tạng Tâm tàng thần**: thần yên thì ngủ; thần không yên thì khó ngủ, hay giật mình.
- Can tàng hồn**: hồn không yên thì **"đa mộng"**, mơ nhiều [C3].
- Thái Nguyên Định (Thái Quý Thông)*, "*Thụy quyết*", đời Nam Tống (**đã kiểm**): **"Tiên thụy tâm, hậu thụy nhãn"**: ngủ lòng trước, ngủ mắt sau. Chu Hy rất đề cao câu này.

6.4. Tàng tinh, dưỡng huyết

- Tố Vấn, "Ngũ tạng sinh thành": "**Nhân ngọa huyết quy ư Can**": người nằm thì huyết về Can.
- Thận tàng tinh; ngủ là lúc **tàng**, như mùa đông của một ngày (*Tứ khí điều thần đại luận*: mùa đông "tảo ngọa văn khởi").

6.5. Bệnh nguyên của mất ngủ (bất寐) trong cổ truyền [C3]

Cổ truyền chia mất ngủ thành hai nhóm lớn:

Nhóm	Thể thường gặp	Biểu hiện điển hình	Liên hệ hiện đại gợi ý 📌
Thực	Can hoả, đàm nhiệt	Khó ngủ, dễ cáu, đầu nặng, miệng đắng	Căng thẳng, tăng kích thích; ăn uống nhiều dầu mỡ, rượu
Thực	Vị bất hoà (Tố Vấn, " <i>Nghịch điều luận</i> ": "Vị bất hoà tắc ngọa bất an")	Đầy bụng, ợ, khó ngủ	Ăn no sát giờ ngủ, trào ngược [C1]
Hư	Tâm Tỳ lưỡng hư	Hay mơ, dễ tỉnh, hồi hộp, ăn kém, mệt	Lo nghĩ kéo dài, suy nhược
Hư	Âm hư hoả vượng, Tâm Thận bất giao	Khó ngủ, nóng bứt rứt, ra mồ hôi đêm	Mãn kinh, căng thẳng kéo dài
Hư	Tâm Đờm khí hư	Dễ giật mình, sợ hãi, ngủ không sâu	Lo âu

Lưu ý: biện chứng thể bệnh là **việc của lương y**. App chỉ dùng bảng này như **khung giải thích văn hoá**, không phân loại người dùng theo thể bệnh.

6.6. Giờ giấc cổ truyền [C3]

- Tý Ngọ giấc:** ngủ giờ Tý (23h-1h), chợp mắt giờ Ngọ (11h-13h).
- Giờ Sửu (1h-3h) kinh Can vượng, giờ Dần (3h-5h) kinh Phế vượng (theo Tý Ngọ lưu chú).

7. Đối chiếu Đông - Tây

Khái niệm cổ truyền	Khái niệm hiện đại gần nhất	Mức tương đồng
Ngày dương, đêm âm; dương vào âm thì ngủ	Đồng hồ sinh học ngày đêm; melatonin tiết khi tối	Tương đồng về hiện tượng [C2]
Dương khí hết thì ngủ	Áp lực ngủ tích tụ khi thức (quá trình S)	Tương đồng về hình ảnh 📌
"Hợp âm" nửa đêm	Ngủ sâu dồn vào đầu và giữa đêm	Tương đồng về hình ảnh 📌
Tàng tinh, dưỡng huyết khi ngủ	Hormone tăng trưởng, phục hồi mô khi ngủ sâu	Tương đồng về chức năng 📌
Thần yên thì ngủ; "tiên thụy tâm"	Tăng kích thích là cơ chế duy trì mất ngủ; CBT-I và thư giãn giảm kích thích	Tương đồng mạnh [C1 về phía hiện đại]

Khái niệm cổ truyền	Khái niệm hiện đại gần nhất	Mức tương đồng
Đa mộng do hồn không yên	Mơ trong REM là bình thường; ác mộng nhiều liên quan căng thẳng, sang chấn	Chỉ tương đồng một phần; không nói "mơ là xấu"
Vị bất hoà tắc ngọa bất an	Ăn no sát giờ ngủ gây trào ngược, khó ngủ	Tương đồng mạnh [C1]
Tý Ngộ giác	Ngủ đúng cửa sổ sinh học; ngủ trưa ngắn tăng tỉnh táo	Phần ngủ trưa ngắn [C1-C2]; giờ Tý cụ thể [C3]
Mùa đông "tảo ngọa văn khởi"	Ngày ngắn, ánh sáng sáng muộn hơn ảnh hưởng nhịp	Tương đồng về hiện tượng [C2]

8. Hậu quả của thiếu ngủ

Hệ cơ quan	Hậu quả	Cấp
Nhận thức	Giảm chú ý, trí nhớ, phán đoán; thiếu ngủ kéo dài gây suy giảm tích lũy mà người thiếu ngủ thường không tự nhận ra	C1
An toàn	Tăng nguy cơ tai nạn giao thông, tai nạn lao động; buồn ngủ khi lái xe nguy hiểm trong tự lái xe khi say	C1
Cảm xúc	Phản ứng cảm xúc mạnh hơn, dễ cáu; mất ngủ là yếu tố nguy cơ của trầm cảm	C1
Chuyển hoá	Giảm độ nhạy insulin; tăng hormone đói (ghrelin), giảm hormone no (leptin); tăng thêm đồ ngọt béo	C1-C2
Tim mạch	Ngủ ngắn kéo dài liên quan tăng huyết áp, bệnh tim mạch	C1-C2
Miễn dịch	Giảm đáp ứng vắc-xin; dễ nhiễm trùng hơn	C1-C2
Đau	Thiếu ngủ làm tăng cảm nhận đau	C2
Ung thư	IARC xếp làm ca đêm là "có thể gây ung thư" (nhóm 2A)	C1-C2

9. Các rối loạn giấc ngủ thường gặp

Rối loạn	Dấu hiệu nhận biết	Điều trị chính	Vai trò của app
Mất ngủ mạn tính	Khó vào giấc, khó duy trì hoặc dậy quá sớm, ≥ 3 đêm/tuần, kéo dài ≥ 3 tháng , ảnh hưởng ban ngày (tiêu chuẩn ICSD-3)	CBT-I là điều trị hàng đầu (hướng dẫn ACP 2016, Hội Nghiên cứu Giấc ngủ châu Âu 2017)	Sàng lọc, khuyên đi khám, hỗ trợ thói quen; cân nhắc hợp tác CBT-I số
Ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn	Ngáy to, người ngủ cùng thấy ngưng thở, thức dậy hỗn hển, buồn ngủ ban ngày, tăng huyết áp khó kiểm soát	Thở áp lực dương liên tục (CPAP), giảm cân, dụng cụ miệng, phẫu thuật tùy trường hợp	Sàng lọc (STOP-Bang), khuyến khám ; không bán thiết bị "chữa ngáy"

Rối loạn	Dấu hiệu nhận biết	Điều trị chính	Vai trò của app
Hội chứng chân không yên	Khó chịu ở chân buổi tối, phải cử động mới đỡ	Khám; kiểm tra thiếu sắt	Nhận biết, khuyên khám
Rối loạn nhịp ngủ - thức (giai đoạn ngủ muộn)	Không ngủ được trước 1-2h sáng, nhưng ngủ ngon nếu được dậy muộn	Ánh sáng sáng, điều chỉnh giờ dưới hướng dẫn	Hỗ trợ ánh sáng, giờ dậy đều
Rối loạn do làm ca	Mất ngủ, buồn ngủ liên quan lịch làm việc	Lịch ngủ, kiểm soát ánh sáng	Lộ trình riêng cho người làm ca
Ngủ rũ	Buồn ngủ dữ dội ban ngày, yếu cơ đột ngột khi cười, xúc động	Chuyên khoa	Nhận biết, khuyên khám
Rối loạn hành vi giấc ngủ REM	Đánh dấm, la hét theo giấc mơ	Chuyên khoa (có thể là dấu hiệu sớm của bệnh thần kinh)	Nhận biết, khuyên khám
Ác mộng, sang chấn	Ác mộng lặp lại, sợ đi ngủ	Trị liệu tâm lý	Nối trự Cảm xúc, khuyên gặp chuyên gia

10. Can thiệp theo cấp bằng chứng

Can thiệp có bằng chứng mạnh [C1]

Can thiệp	Ghi chú
CBT-I cho mất ngủ mạn tính	Hiệu quả bền hơn thuốc ngủ; có dạng số (dCBT-I) đã được thử nghiệm
Giờ thức dậy cố định	Thành phần cốt lõi của CBT-I
Kiểm soát kích thích	Chỉ lên giường khi buồn ngủ; nằm lâu không ngủ được thì ra khỏi giường
Ánh sáng buổi sáng, giảm sáng buổi tối	Chỉnh đồng hồ sinh học
Tránh caffeine buổi chiều tối	Drake và cộng sự 2013: caffeine uống 6 giờ trước ngủ vẫn giảm giấc ngủ
Không dùng rượu để ngủ	Rượu làm vỡ giấc nửa sau, giảm REM
Ăn xong 2-3 giờ trước ngủ	Giảm trào ngược
Điều trị ngưng thở khi ngủ (khi được chẩn đoán)	Cải thiện buồn ngủ ban ngày, huyết áp

Can thiệp có bằng chứng vừa [C2]

Can thiệp	Ghi chú
Tắm hoặc ngâm nước ấm 40-42,5 °C, 1-2 giờ trước ngủ, dù chỉ 10 phút	Rút ngắn thời gian vào giấc, cải thiện chất lượng ngủ (phân tích gộp Haghayegh và cộng sự, <i>Sleep Medicine Reviews</i> 2019, 17 nghiên cứu) (đã kiểm)
Vận động thể lực	Vận động cấp tính có lợi ích nhỏ cho thời gian ngủ, thời gian vào giấc, hiệu quả giấc ngủ và ngủ sâu; vận động đều đặn có lợi ích vừa cho chất lượng giấc ngủ (phân tích gộp Kredlow và cộng sự, <i>J Behav Med</i> 2015, 66 nghiên cứu) (đã kiểm)
Thiền chánh niệm, thư giãn, thở chậm	Cải thiện chất lượng ngủ ở mức vừa
Ngủ trưa ngắn 10-30 phút	Tăng tỉnh táo; không bù được giấc ngủ đêm
Phòng ngủ tối, yên, mát	Đồng thuận lâm sàng, bằng chứng thử nghiệm hạn chế
Hạn chế màn hình trước ngủ	Tác động thực tế nhỏ hơn quảng cáo; nội dung kích thích quan trọng hơn ánh sáng xanh

Bằng chứng yếu hoặc chưa đủ [C2-C3]

Can thiệp	Ghi chú
Trà hoa cúc, tinh dầu oải hương	Bằng chứng nhỏ
Chăn trọng lượng	Kết quả chưa thống nhất
Âm thanh kích thích sóng chậm (pink noise đồng bộ sóng não)	Mới ở mức thí nghiệm
Thảo dược an thần cổ truyền (lạc tiên, tâm sen, lá vông...)	Kinh nghiệm dân gian; cần lương y và an toàn
Melatonin	Có vai trò trong rối loạn nhịp (lệch múi giờ, ngủ muộn) dưới hướng dẫn y tế ; không phải lựa chọn hàng đầu cho mất ngủ mạn tính

Không khuyến khích

- **Rượu để dễ ngủ.**
- **Tự dùng thuốc ngủ** không theo chỉ định.
- **Theo đuổi điểm số giấc ngủ của thiết bị** đến mức lo âu.

11. Đo lường giấc ngủ

Phương pháp	Đo được	Độ chính xác	Dùng trong app
Đa ký giấc ngủ (PSG) tại phòng xét nghiệm	Sóng não, giai đoạn ngủ, hô hấp, oxy, cử động	Tiêu chuẩn vàng	Không; chuyển khám khi cần
Đo hô hấp tại nhà	Ngưng thở khi ngủ	Tốt cho chẩn đoán ngưng thở	Không; chuyển khám
Actigraphy (thiết bị đo cử động chuẩn y khoa)	Thời gian ngủ - thức	Khá	Không
Thiết bị tiêu dùng (đồng hồ, nhẫn)	Thời lượng ngủ, nhịp tim	Thời lượng khá tốt; giai đoạn ngủ kém chính xác [C2]	Tham khảo, không làm mục tiêu
Nhật ký giấc ngủ	Giờ đi ngủ, giờ dậy, thời gian vào giấc, thức giấc, cảm nhận	Chủ quan nhưng là công cụ chuẩn trong CBT-I	Công cụ chính
Bảng hỏi chuẩn hoá	ISI (mất ngủ), PSQI (chất lượng ngủ), ESS (buồn ngủ ban ngày), STOP-Bang (ngưng thở)	Đã thẩm định quốc tế; cần bản tiếng Việt	Định kỳ

Chỉ số tự cảm nhận quan trọng nhất: "Sáng nay bạn thấy đã được nghỉ đến đâu?" (0-10). Chỉ số này phản ánh chất lượng giấc ngủ thực tế tốt hơn bất kỳ "điểm ngủ sâu" nào.

12. Ứng dụng cho Cội Wellness 🍃

12.1. Phân loại người dùng theo vấn đề giấc ngủ

Thay vì một lộ trình chung, app phân người dùng vào **năm kiểu** dựa trên nhật ký 1-2 tuần và bảng hỏi:

Kiểu	Dấu hiệu	Lộ trình
A. Thiếu ngủ do lịch	Ngủ dễ, ngủ ngon nhưng ngủ dưới 7 giờ vì thức khuya, dậy sớm	Lùi dần giờ ngủ; ranh giới buổi tối; màn hình
B. Khó ngủ do tâm	Nằm lâu không ngủ được, đầu óc chạy, lo nghĩ	"Gác lại ngày", thở, quy tắc 20 phút; nếu mạn tính → khám, CBT-I
C. Ngủ không sâu, mệt dù đủ giờ	Ngủ đủ giờ nhưng sáng vẫn mệt, ngáy	Sàng lọc ngưng thở trước; rượu, cà phê, phòng ngủ
D. Lềch nhịp	Ngủ muộn, dậy muộn, khó dậy sáng; hoặc làm ca	Ánh sáng sáng, giờ dậy cố định; lộ trình ca đêm
E. Giấc ngủ ổn	Ngủ đủ, sáng tỉnh táo	Duy trì; ưu tiên trụ khác

Một người có thể thuộc nhiều kiểu. **Cờ đỏ luôn được kiểm tra trước** khi phân kiểu.

12.2. Chuỗi xử lý khi người dùng ngủ kém

- 1. **Kiểm tra cò đồ:** ý nghĩ tự hại; ngủ gật khi lái xe; dấu hiệu ngưng thở khi ngủ; mất ngủ mạn tính; ngủ nhiều và mệt kéo dài.
- 2. **Hỏi ba hướng** (lý luận mục IV.3): Vị bất hoà (bữa tối, cà phê, rượu) → cửu thị (màn hình, ánh sáng) → tâm động (lo nghĩ).
- 3. **Chọn 1-2 việc** theo kiểu người dùng và tiêm tiến.
- 4. **Đo lại sau 2 tuần** bằng nhật ký và chỉ số "đã được nghỉ".
- 5. Nếu không cải thiện sau 4-6 tuần, hoặc đủ tiêu chuẩn mất ngủ mạn tính → **khuyến đi khám**.

12.3. Nội dung và tính năng ưu tiên

Ưu tiên	Tính năng	Cấp bằng chứng của nội dung
1	Nhật ký giấc ngủ buổi sáng (30 giây)	Công cụ chuẩn
2	Neo giờ dậy, đón nắng sáng, "hoàng hôn trong nhà"	C1
3	Bộ âm thanh trước ngủ: thở, quét thân, "gác lại ngày"	C2
4	Nhắc cà phê, bữa tối, rượu (nối trụ Ăn uống)	C1
5	Gợi ý ngâm chân, tắm ấm 1-2 giờ trước ngủ	C2
6	Sàng lọc ISI, ESS, STOP-Bang định kỳ	Công cụ chuẩn
7	Hợp tác CBT-I số, kết nối khám giấc ngủ	C1

12.4. Cách nói Đông - Tây (mẫu)

- "Người xưa dạy *tiên thụ tâm, hậu thụ nhãn*, ngủ lòng trước, ngủ mắt sau. Khoa học ngày nay cũng thấy đầu óc căng thẳng là nguyên nhân chính khiến mất ngủ kéo dài, và các phương pháp làm dịu tâm trí trước ngủ giúp ngủ ngon hơn."
- "*Nội Kinh* gọi giấc nửa đêm là *hợp âm*. Ngày nay ta biết giấc ngủ sâu nhất dồn vào đầu đêm, lúc cơ thể tiết hormone phục hồi. Ngủ muộn là bỏ lỡ một phần quý nhất của đêm."

13. Câu hỏi nghiên cứu mở cho Lục Dưỡng

Các câu hỏi phù hợp với **thang kiểm chứng** của lý luận (mục IX):

Câu hỏi	Bậc kiểm chứng phù hợp
Với từng người, ngâm chân nước ấm buổi tối có rút ngắn thời gian vào giấc không?	Bậc 2: thử nghiệm N-of-1 (xen kẽ ngẫu nhiên tuần có, tuần không)
Dời ly cà phê cuối trước 14h có cải thiện chỉ số "đã được nghỉ" không?	Bậc 2
Ở người Việt dùng app, giấc ngủ trưa dài liên quan thế nào đến giấc ngủ đêm?	Bậc 3: dữ liệu tổng hợp ẩn danh (chỉ tạo giả thuyết)

Câu hỏi	Bậc kiểm chứng phù hợp
Mùa nồm, mùa nóng ảnh hưởng giấc ngủ người dùng miền Bắc và miền Nam thế nào?	Bậc 3
Lộ trình ngủ theo năm kiểu có hiệu quả hơn lộ trình chung không?	Bậc 4: nghiên cứu có đối chứng, cần hội đồng đạo đức và đối tác học thuật
Trà thảo mộc Việt (tâm sen, lạc tiên) có cải thiện giấc ngủ so với giả dược không?	Bậc 4; cần lương y, bác sĩ, kiểm định chất lượng

14. Nguồn

Đã đối chiếu sơ bộ qua tra cứu trực tuyến (05/10/2026)

- *Linh Khu*, "*Khẩu vấn*", câu "Dương khí tận, âm khí thịnh, tắc mục minh...": [Trung y thế gia](#), [Đạo âm văn hoá](#)
- *Linh Khu*, "*Doanh vệ sinh hội*", câu "Dạ bán nhi đại hội... mệnh viết hợp âm": [Hoàng Đế Nội Kinh vãng](#), [Tri Hồ](#)
- Thái Nguyên Định, *Thụy quyết*, câu "Tiên thụy tâm, hậu thụy nhãn": [The Paper](#), [Cục Quản lý Trung y dược Quảng Đông](#)
- Haghayegh và cộng sự 2019, *Sleep Medicine Reviews*, tắm ấm trước ngủ: [ResearchGate](#), [ScienceDaily](#)
- Kredlow và cộng sự 2015, *Journal of Behavioral Medicine*, vận động và giấc ngủ: [ResearchGate](#), [Semantic Scholar](#)
- Mất ngủ ở cộng đồng TP.HCM: [Bệnh viện Tâm thần TP.HCM](#)
- Mất ngủ ở sinh viên TP.HCM: [Tạp chí Y học Việt Nam](#)
- Mất ngủ ở người trẻ: [VnExpress](#)
- Ước tính trên 10 triệu người Việt có vấn đề giấc ngủ: [Sở Y tế Nghệ An](#)

Chưa đối chiếu, cần kiểm tra trước khi trích dẫn

- Borbély 1982 (mô hình hai quá trình); khuyến nghị AASM và SRS 2015; National Sleep Foundation 2015.
- Xie và cộng sự 2013 (glymphatic); Tasali và cộng sự 2008 (ngủ sâu và insulin); Mander và cộng sự 2013 (ngủ sâu và trí nhớ ở người cao tuổi); Tononi và Cirelli (cân bằng khớp thần kinh).
- Drake và cộng sự 2013 (caffeine 6 giờ trước ngủ).
- Hướng dẫn điều trị mất ngủ ACP 2016 và Hội Nghiên cứu Giấc ngủ châu Âu 2017; tiêu chuẩn ICSD-3.
- *Tổ Vấn* các thiên "Ngũ tạng sinh thành", "Nghịch điều luận", "Tứ khí điều thần đại luận"; các thể bất mị trong y văn cổ truyền.
- IARC về làm ca đêm (nhóm 2A).